FORMAÇÃO EM PSIQUIATRIA
SOMATOPSÍQUICA

Aula 2

Presença

Habitando a própria experiência

FASE 1 · HABITAR O CORPO

Guia de apoio à aula e à prática da semana

Presença, codificação preditiva, tradução clínica
e vivência completa dos 7 passos da IPS.

Dra. Renata Guerra

Retome este material junto ao diário de prática e às fichas
disponíveis na área de membros.

A PERGUNTA QUE ABRE A AULA

Presença e contato com a experiência

É possível mudar aquilo que não percebemos?

Antes da mudança, existe a percepção. Antes da percepção, existe a presença.

Na aula, presença é o contato com a experiência que acontece agora: sensações e postura, tonalidade afetiva, conteúdo mental e ambiente. Esse contato pode ampliar a possibilidade de perceber antes de reagir.

Piloto automático

O piloto automático economiza esforço, mas pode reduzir a escolha. Quando a experiência passa despercebida, a sequência gatilho, reação e resultado parece acontecer sozinha.

Uma pausa de 30 segundos

Feche os olhos, se for confortável. Pergunte: "O que percebo agora?" Não procure uma resposta certa. Apenas note o que chega primeiro.

Descrição antes da interpretação

A frase "Estou ansioso" reúne um rótulo e uma interpretação. "Meu peito está apertado" descreve uma sensação percebida. A descrição corporal ajuda a explorar a experiência sem apressar explicações.

O que percebo agora no corpo, nas emoções, nos pensamentos e no ambiente?

DOIS MODOS DE CONHECER A SI MESMO

Narrar e experienciar

MODO NARRATIVO	MODO EXPERIENCIAL
Pensar sobre a experiência. O que isso significa? Por que aconteceu? O que devo fazer?	Sentir a experiência. O que percebo agora? Como aparece no corpo? O que muda momento a momento?

A competência está na flexibilidade

A clínica ganha profundidade quando o paciente consegue pensar sobre o que vive e sentir o que está vivendo. Os dois modos podem se alternar. Perder-se em pensamentos e voltar à experiência faz parte do treino.

Durante a prática

Pergunte-se: "Estou pensando sobre a experiência ou estou vivendo a experiência?"

Frequentemente percebemos a história antes do corpo

Pensamentos, preocupações e imagens podem chegar primeiro à consciência, enquanto respiração, postura, tensão, temperatura e vitalidade passam despercebidas.

O que ajuda você a retornar da história para a experiência presente?

MODELO DE CODIFICAÇÃO PREDITIVA

Como o cérebro estima o estado do corpo

A experiência corporal consciente pode ser compreendida como uma estimativa que integra expectativas prévias, sinais atuais do corpo e contexto.

Expectativa prévia

O que o cérebro espera a partir do que aprendeu.

Sinais atuais

Informações corporais que chegam agora.

Erro de previsão

Quando o esperado e o recebido diferem, surge uma discrepância. Neste uso, "erro" significa diferença, não falha.

Inferência perceptual

Os sinais podem ajudar a atualizar a estimativa. A pessoa pode reconhecer: "Eu esperava estar tranquila e percebo que meu corpo está mais ativado". Os batimentos podem permanecer iguais enquanto a estimativa muda.

Inferência ativa

A ação pode modificar os sinais recebidos. Uma pausa intencional e um ajuste da respiração podem alterar o estado corporal. Inferência perceptual e ativa podem acontecer juntas.

Agência e senso de agência

Agência é a capacidade de agir e produzir efeitos. Senso de agência é a experiência de ser autora da ação. A participação existe mesmo quando os efeitos da ação são limitados.

TRADUÇÃO PARA A IPS

Presença, empatia e espaço de resposta

Presença corporal

Reconhecer o que acontece em mim.

Presença relacional

Estar com o outro sem fusão nem afastamento. Presença e empatia compartilham elementos de suas redes, mas não são processos idênticos.

A presença pode ampliar o espaço de resposta

Gatilho, perceber, escolher e agir. Perceber pode ampliar as possibilidades de escolha. A presença não elimina a experiência difícil e o desconforto pode continuar.

Do artigo ao consultório

Em vez de perguntar apenas "Por que você fez isso?", acrescente: "O que você percebeu instantes antes?" A pergunta desloca a atenção da justificativa retrospectiva para a reconstrução da sequência vivida.

Evidências para a prática clínica

- Mindfulness foi proposto como autorregulação da atenção com atitude de abertura e aceitação.
- A atenção ao presente pode recrutar padrões de autorreferência distintos da elaboração narrativa.
- Maior atenção consciente no cotidiano associa-se a indicadores de bem-estar e autorregulação.

A presença não elimina a experiência difícil. Ela muda a relação com o que está acontecendo.

CUIDADO CLÍNICO

Contato, oscilação e segurança

O contato com a experiência pode oscilar ao longo de um espectro: presença, oscilação, desconexão e dissociação. No polo de maior desconexão podem aparecer despersonalização e desrealização.

Sinais de baixa presença na consulta

- Respostas rápidas, prontas ou excessivamente intelectualizadas.
- Dificuldade para nomear emoções ou descrever sensações.
- Impulsividade e pouca percepção dos gatilhos.
- Desconforto intenso diante de pausas e silêncio.

Esses sinais não são diagnósticos. São convites para investigar.

Quando diminuir o ritmo

Presença deve ser convidada, não imposta.

- Ofereça olhos abertos, orientação ao ambiente e possibilidade de interromper.
- Prefira doses breves diante de hiperativação, entorpecimento ou desconforto crescente.
- Em sintomas dissociativos relevantes, avalie contexto, estabilidade e indicação clínica.

Antes dos 7 passos

Por um instante, não queremos resolver nem melhorar nada. Queremos apenas perceber. Depois da pausa, escolhemos algo para transformar e iniciamos os 7 passos.

A VIVÊNCIA DA AULA 2

Os 7 passos da IPS - Modo Transformação

A aula apresenta o percurso completo em uma única prática. Cada passo será aprofundado ao longo da formação. Nesta vivência, o objetivo é experimentar a sequência inteira.

Antes de iniciar

O que desejo transformar em minha vida neste momento?

1. Presença e enraizamento

Pés paralelos, joelhos destravados, chegada ao corpo aqui e agora e respiração livre. No grounding bioenergético, acompanhe a demonstração, cuide do equilíbrio e respeite seus limites.

2. Mapeamento Somatopsíquico

Percorra o corpo dos pés à cabeça. Explore a sensação em localização, temperatura, textura, forma, cor e som, conforme percebidos. Depois do corpo, observe emoções e pensamentos sem apressar interpretações.

3. Agência Somatopsíquica

Retome a sensação mapeada, escute o que o corpo necessita e permita uma resposta corporal própria. Um movimento, uma postura ou um som podem emergir. Adapte, pause ou interrompa quando precisar.

4. Remapeamento Somatopsíquico

Volte às sensações corporais e compare com o mapeamento inicial. Reconheça também emoções e pensamentos. Observe mudanças e permanências sem exigir melhora.

A VIVÊNCIA DA AULA 2

Passos 5, 6 e 7

5. Insight Somatopsíquico

Coloque as mãos sobre o peito e feche os olhos, se for confortável. Aguarde uma palavra, frase ou imagem. Acolha o que surgir sem forçar uma resposta. Se nada aparecer, reconheça isso.

Pergunta central

Que palavra, frase ou imagem emerge desta experiência?

6. Atenção Plena e silêncio meditativo

Permaneça por um momento com o que acontece agora. Perceba corpo, respiração, sons e estímulos internos e externos. Quando notar que se perdeu em pensamentos, retorne gentilmente. Perceber a distração e voltar faz parte da prática.

Pergunta central

O que percebo agora quando permaneço com a experiência?

7. Fechamento e integração

Reconheça o percurso e aproxime a experiência da questão escolhida. Compartilhe apenas o que desejar. Na clínica, o profissional auxilia a relacionar o vivido com a história de vida e o contexto atual.

Pergunta central

O que levo desta vivência e como isso se relaciona com minha vida?

Durante a prática

Observe a alternância entre pensar sobre a experiência e viver a experiência. Há espaço para o que emerge e para o que ainda não aparece.

DO ARTIGO AO CONSULTÓRIO

Pausa Somatopsíquica

Um minuto pode mudar a qualidade da consulta

Use a pausa antes de uma decisão, transição ou resposta automática. Observe, nesta ordem:

1. Corpo
2. Emoções
3. Pensamentos

Sem corrigir. Sem interpretar. Sem mudar.

Prática da semana

Pausa Somatopsíquica - três vezes ao dia

Durante um minuto, pergunte: "O que estou percebendo agora no corpo, nas emoções e nos pensamentos?" Registre uma observação por dia.

Grounding e mapeamento - uma vez ao dia

Pratique grounding e mapeamento somatopsíquico uma vez ao dia, respeitando as orientações e os limites apresentados na aula.

Compartilhamento e integração

- O que foi mais fácil perceber?
- O que foi mais difícil?
- Em que momento você se afastou da experiência?
- O que ajudou você a voltar?
- Como foi permanecer sem tentar mudar?

Uma observação que quero registrar hoje:

INTEGRAÇÃO E CONTINUIDADE

O que levo deste encontro?

O que apareceu no meu corpo durante a vivência?

O que apareceu nas emoções e nos pensamentos?

O que mudou e o que permaneceu após a Agência?

Que palavra, frase ou imagem emergiu?

Biblioteca Somatopsíquica

Leitura essencial: Farb & Segal, *Better in Every Sense*, especialmente os capítulos sobre sensação, piloto automático e modos de autorreferência.

Artigos-base indicados na aula: Farb et al. (2007), Brown & Ryan (2003) e Bishop et al. (2004). Para modelo interoceptivo e agência: Farb et al. (2015), doi: 10.3389/fpsyg.2015.00763; Moore (2016), doi: 10.3389/fpsyg.2016.01272.

A transformação não começa quando mudamos. Ela começa quando percebemos.

Base deste guia: apresentação revisada da Aula 2, de Dra. Renata Fáro Guerra. Síntese didática para os participantes da formação. Conceitos e orientações seguem os materiais da autora.